

UD3 — TGA Viol. Fliar. y Género, Córdoba, A.I. N.º 2, 05/09/2025, “Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba — Denuncia por Violencia de Género” [...] Y VISTOS: Estos autos caratulados: “Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba — Denuncia por Violencia de Género — Ley 10.401-” (Expte. SAC N° 9106721), traídos a despacho a los fines de resolver el incidente planteado en los términos del artículo 12 de la Ley 10.401; DE LOS QUE RESULTA: Con fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés ingresó denuncia de violencia de género formulada por S. A. M. en su carácter de presidente de la asociación civil “Casa de Varones Trans y Familias Córdoba” en contra del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba por entender que se cometió violencia de tipo simbólica, con modalidad mediática, institucional y de manera indirecta contra los derechos sexuales de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Con fecha veintiséis de junio de dos mil veintitrés se certificó que se procedió a la consulta online de la página del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, ingresando al programa del curso de actualización de Medicina General siendo uno de los temas Disforia de Género. Adolescencia: Patologías frecuentes, etc., sífilis. Cuidados en medicina familiar pre y pro anestésicos, con inicio de dictado el día 02/05/2023 y cierre de inscripción el día 31/05/2023. Con fecha treinta de junio de dos mil veintitrés se resolvió inaudita parte —como medida cautelar urgente— lo siguiente (txt): “...1) Ordenar al presidente de la junta directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, que arbitre los medios necesarios para que el módulo titulado “Disforia de Género” se readecue conforme los parámetros establecidos por el “Plan Nacional de Políticas de Género y Diversidad ena Salud Pública”, sugiriéndose como título de la capacitación: “Atención de la salud integral de personas trans, travestis y no binaries”, toda vez que el término “Disforia de Género” al provenir de la rama de la psiquiatría propicia un enfoque patologizante al colectivo de mención. 2) Dese noticia de la medida dispuesta al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba a sus efectos. 3) Notifíquese.” Con fecha trece de septiembre de dos mil veintitrés se imprimió el trámite incidental previsto por el artículo 12 de la Ley 10.401, corriéndose traslado de ley a la parte denunciada. Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés se otorgó participación al abogado A. E. C. en carácter de apoderado del Consejo de médicos de la Provincia de Córdoba. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés evacuó traslado la parte demandada negando que las conductas que se endilga constituyan violencia de género y que se trató de una mención

desactualizada y mal escrita de un tema. Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil veintiséis se proveyó tener por evacuado el traslado, fijar audiencia con las partes en los términos del artículo 15 de la Ley 10.401, tener presente la presentación de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y requerir al Ministerio de Salud respuesta al oficio librado oportunamente autorizándose a su diligenciamiento a los letrados. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinticuatro se agregó la constancia de ingreso del oficio en el SUAC del Ministerio de Salud el que fuere diligenciado por la Dra. B. Con fecha ocho de marzo de dos mil veinticuatro, mediante escrito por despacho diario el apoderado del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba instó la suspensión de la audiencia calendarizada acompañando cédula electrónica de otra causa donde coincide la fecha de audiencia y al haber sido fijada con anterioridad se proveyó hacer lugar a lo requerido ordenando la calendarización de una nueva fecha de audiencia. Con fecha veinte de marzo de dos mil veinticuatro fueron escuchados en audiencia el Sr. S. A. M., en su carácter de presidente de la Asociación Civil casa de Varones Trans y Familias Córdoba con la asistencia técnica de su abogada M. L. B., momento en el cual expresó lo siguiente (txt): “Desde que tengo tres años me percibo varón y he sufrido estas violencias estructurales y la situación de que te tienen que llevar a terapia para que entiendas que no sos varón. Al aparecer la ley de identidad de género por nuestras luchas, aparece no solo el derecho de ser quien soy sino que incorpora también a las niñeces y adolescencias. No fue así nomás, se incorporaba valoraciones psicológicas y psiquiátricas para poder ser o no ser quien te percibes. Todo eso fue un circuito de patologización que termina en el dos mil doce con nuestra ley de identidad de género. Cuando nos encontramos con esta publicación del Consejo de Médicos de Córdoba, incorporaron un término que patologiza nuevamente, con un material ya caduco. Un curso de actualización no puede utilizar un material obsoleto. Yo vengo de tras la sierra, en el interior es tremendo el correctivo de un familiar para que te haga entender cuál es tu sexualidad. El caso Tehuel es un caso testigo de lo que sucede. Esta palabra disforia trae asociado las violencias estructurales. En el sistema educativo hay expulsiones sutiles también. En relación a la medida tomada por el juzgado, llama la atención que el Consejo de Médicos no lo haya recibido porque es el correo oficial de la página. No se acompaña prueba de que hayan cumplido con la medida. Nosotros hacemos articulaciones con distintos hospitales como el Hospital de Niños y el Hospital Infantil, el Benito Soria donde está la Dra.

Lagger, entre otros, donde hay profesionales amigables que tienen formación y humanidad. La Dra. L. me llamó para que de una charla y ella no estaba en el temario inicial. Di la charla el doce de agosto con otras personas de forma virtual, pero quiero que quede claro que ese llamado fue posterior a mi denuncia. También fue posterior a la denuncia el cambio del nombre del curso, ya que se llamaba Disforia de género y pasó a llamarse Módulo de atención integral de salud en clave de género, diversidad y derechos humanos. De la forma en que lo cuentan pareciera que formara participación del módulo desde un primer momento. De buena fe hubiera sido que reconozcan el error y se reivindicueso. Me gustaría saber quién controla el material de lo que se va a dar y cuál era el material que se utilizó en el curso, porque para errar así deben haber seguido cierta bibliografía.” A su turno la abogada M. L. B., dijo (txt): “Acompaño los dichos de mi patrocinado, solicitando que se tenga presente que no hubo un reconocimiento del error ni mucho menos una reivindicación por lo sucedido. En definitiva, solicitamos que S.S. en su función pedagógica y siendo una temática de interés público, que determine que se estuvo frente a un caso de violencia de género en la modalidad denunciada y que el Consejo Médico reivindique la situación de mi patrocinado porque fue revictimizado porque si el Consejo le hubiera dicho a mi patrocinado que en el marco del error quería que diera la charla, lo hubiera tomado como una reivindicación y no fue así, porque lo ha llamado la Dra. L. que siempre lo suele convocar para las charlas. Además lo grabaron sin preguntarle si autorizaba a ello. La idea de que el médico tiene que adecuar la psiquis o adecuar el cuerpo posicionado en una postura binaria es una concepción productora de violencia. Finalmente manifiesto que el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba no forma parte de la Federación Argentina de Medicina General, quien apoya la asociación de mi patrocinado.” En dicho acto se proveyó tener presente lo manifestado y estar a la próxima audiencia. Con fecha tres de abril de dos mil veinticuatro fueron escuchados en audiencia el Titular del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, el Sr. H. R. O., asistido técnicamente por el apoderado A. E. C., momento en el cual expresó lo siguiente (txt): “La situación parte de un mal entendido y de un error de parte de un empleado que cargó un texto antiguo del curso. Pusieron erróneamente el título disforia de un curso anterior que era antiguo. De hecho el denunciante estuvo invitado a dar la charla de género por su conocimiento en el tema. En el curso se publican los temas de interés para la actualización, donde se convocan los disertantes pero no se publica la bibliografía. Se trató de un lamentable desmanejo administrativo y

podemos entender la preocupación del denunciante, pero no hubo intención de tratar el tema con conceptos viejos ni nada por el estilo. Reitero que se trató de un error y se habló el tema con quienes trabajan las cuestiones administrativas. Nos gustaría que se traslade al denunciante que se lamenta el error administrativo.” A su turno el abogado A. E. C., dijo (txt): “Acompaño los dichos de mi patrocinado, se ha tratado de un error administrativo que fue corregido posteriormente y se lamenta.” En dicho acto se resolvió pasar los autos a despacho para proveer. Con fecha quince de mayo de dos mil veinticuatro se proveyó correr traslado de lo manifestado en la audiencia al Sr. S. A. M. con su respectivo patrocinio letrado. Con fecha veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro evacúa traslado el Sr. S. A. M. con su respectivo patrocinio letrado destacando que no se aceptan las disculpas porque no se ha tratado de un error y no se arrió prueba al proceso para demostrar que fue un error del personal administrativo. Destacó además la importancia de tener en cuenta especialmente el cuidado y acompañamiento que deben tener los niños, niñas y adolescentes trans en medio de la violencia estructural que sigue teniendo altos índices de adolescentes y jóvenes con autolesiones que vienen de entornos de expulsión, hostigamiento y/o abuso solo por ser quienes son, solo por sentir lo que sienten, con depresión, con trastornos alimenticios, con problemas respiratorios, problemas familiares, entre otros. Dictado y firme el decreto de autos, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta. Y CONSIDERANDO: La competencia material de la suscripta en el proceso deviene de lo prescripto por el art. 7 de la Ley Provincial nº 10.401 y se considera los diferentes instrumentos ratificados por el Estado Argentino en materia de género. 1.a: Normativa Internacional: Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer ratificada internamente por ley Nacional 23.179 (CEDAW). 1.b: Normativa Regional: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ratificada internamente por ley Nacional 24.632 (“Belém do Pará”). 1.c: Normativa Nacional: La Ley de identidad de género establece que todas las personas e instituciones debemos respetar la identidad de género con la que se identifica cada persona, a esto se le llama identidad auto-percibida (Ley de Identidad de Género n.º 26.743, especialmente, en sus arts. 1, 2, 3, 11 y 12.) 1.d: La Ley Nacional de Salud Mental nº 26.657 en el artículo 3 explica que la orientación sexual o la identidad sexual de las personas no pueden ser factores en los que se fundamente de forma exclusiva un diagnóstico. 1.d-Normativa provincial: Si bien el artículo 2 de la Ley 10.401 no prevé el

supuesto de violencia hacia otras identidades por cuestiones de género, entiendo que debe ampliarse su aplicación en consonancia con la presentación efectuada en estos actuados la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), cuyas manifestaciones se tuvieron presentes para su oportunidad (ver decreto de fecha 26/12/2023)— en atención a las obligaciones asumidas por el estado Argentino de ajustar sus normas para evitar discriminaciones. En adición a ello, mediante Acuerdo Reglamentario n° 1910, Serie “A” del cte. año, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó el Protocolo de actuación para el acceso a la justicia en casos que involucran la diversidad sexual y de género, tratándose de una herramienta elaborada en el marco del Programa de investigación-acción para el acceso a la justicia de sectores en condición de vulnerabilidad —Programa AJuV— (TSJ Ac. 664, Serie A, 11/09/17 y AR 1724/A 01/10/2021)— de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba, teniendo como finalidad brindar material de consulta diaria a todo el personal judicial, sin distinción de fueros y funciones, en aras de garantizar la aplicación del ordenamiento jurídico vigente y promueva la erradicación de barreras para el acceso a la justicia de sectores que han sido históricamente discriminados por su orientación sexual, su identidad o su expresión de género. 1.e: Marco Jurisprudencial: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que: “Resulta importante recordar que la falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido” (párrafo 83, Opinión Consultiva 24-17). El aspecto nodal a resolver es, si en el caso bajo estudio el hecho denunciado configura violencia de tipo simbólica, con modalidad mediática, institucional y de manera indirecta contra los derechos sexuales de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Análisis integral de las constancias obrantes: Entiendo insoslayable puntualizar que el colectivo que nos ocupa ha sido históricamente estigmatizado, patologizado y criminalizado en nuestra sociedad. Con el avance de los debates y las luchas de grupos activistas LGBTIQ+ y de los derechos humanos a nivel internacional, se construyó un nuevo paradigma superador de la perspectiva patologizante que defiende el reconocimiento legal de la identidad de género de todas las personas, sin necesidad de requisitos psico-médicos y/o jurídicos, así

como su capacidad para tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo. El Estado Argentino, a partir de la aprobación de la Ley 26.743, se comprometió con el paradigma de la des-patologización y para su efectivo cumplimiento se propuso como desafío avanzar hacia un modelo de atención centrado en una perspectiva de derechos y en las necesidades singulares de cada persona. La Organización Mundial de la Salud publicó la nueva clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) retirando de la categoría de trastorno mental a la transexualidad y travestismo, lo que se conoce como “Disforia de Género” por el DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) publicado por la APA (América Psychiatric Association), y que antes estaban agrupados dentro del capítulo de “Trastornos mentales y del comportamiento” de la CIE-10, encontrándose actualmente agrupados en el capítulo de “condiciones relativas a la salud sexual” bajo el nombre de “incongruencia de género”, tema no exento de debates en la actualidad puesto que el término incongruencia sostiene una comprensión biologicista binaria. Sin perjuicio de ello, la reforma de la CIE-11 abrió un escenario que busca garantizar el derecho a la salud de las personas trans, fue aprobado en el año 2019 por la Asamblea Mundial de la Salud y entró en vigor el 1 de enero de 2022. Teniendo en cuenta el cambio de paradigma imperante donde se deslegitima la patologización de la identidad de género (Ley 26.743 de Identidad de Género) y lo previsto por el art. 3 de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657), donde se especifica que en ningún caso puede hacerse un diagnóstico en salud mental sobre la base exclusiva de “la falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona o la elección o identidad sexual”, fue que previo al dictado de las medidas cautelares instadas, se certificó en sede judicial que se llevó a cabo una consulta on line de la página del Consejo Médicos de la Provincia de Córdoba donde se observó que figuraba dentro del programa de actualización de Medicina General, de Cabecera y la Comunidad como uno de los temas Disforia de Género. Adolescencia: Patologías frecuentes, etc., sífilis. Ello llevó al dictado del decreto que ordenaba a la junta directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba que arbitre los medios necesarios para que el módulo titulado “Disforia de Género” se readecue conforme los parámetros establecidos por el “Plan Nacional de Políticas de Género y Diversidad en la Salud Pública”, sugiriéndose como título de la capacitación: “Atención de la salud integral de personas trans, travestis y no binaries”, toda vez que el término “Disforia

de Género” al provenir de la rama de la psiquiatría propicia un enfoque patologizante al colectivo de mención. Dicha medida fue notificada al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba para su conocimiento y efectos. Posterior a ello, la demandada negó los hechos aduciendo que se trató de un error administrativo, corrigiéndose el título y aclarando que la charla fue dada por el demandante posteriormente. Agregó que no ingresó a la casilla de correo Del Consejo Médico el oficio del juzgado y que tomaron conocimiento cuando ingresó el mismo en soporte papel. Asimismo argumentaron lo siguiente (txt): “El estudio sobre el sufrimiento como consecuencia de una incongruencia de lo que anatómicamente es y lo que psicológicamente siente, no es para nada discriminatorio, ya que lo que se pretende es acompañar psicológicamente y de ser necesario adaptar anatómicamente a quienes presentan esta situación con el fin de lograr su bienestar físico y psicológico. En los casos que se requiere tratamiento, el mismo consiste en aliviar la angustia de los pacientes y ayudarlos a adaptarse en lugar de disuadirlos de su identidad.” “El estudio de la semiología de la afectividad, ámbito del saber médico y muy estudiado por uno de los pilares fundamentales de la psiquiatría, como lo es el estudio de la Psicopatología general, define a la Disforia como un síntoma (es decir todo aquello que un paciente puede referirnos) y como un signo (es decir una cualificación que el médico construye) que nos habla de un estado de la afectividad en el que alguien puede expresarse inconfortable, con expresión de desagrado, con expresión de insatisfacción, inquieto, con presencia de gran ansiedad y con estado de ánimo triste. Todos estos sentimientos y emociones oscilan continuamente, dando al observador la impresión de un estado de ánimo cambiante. Por lo dicho, no se trata en sí de una categoría diagnóstica que pudiera dar cuenta de enfermedad alguna. Si debe ser considerada, como, el disparador de una demanda de atención por parte del médico de cabecera o bien del especialista. “Posterior a ello, las partes fueron escuchadas en audiencia, tal como lo relatara previamente, donde la demandada expresó disculpas por el error y la demandante no aceptó a razón de que al momento de evacuar el traslado la demandada en la parte donde refiere que se pretende acompañar psicológicamente no sigue las recomendaciones del protocolo del Ministerio de Salud, tratándose de un posicionamiento patologizador. Más allá de la posición exculpatoria entiendo que no es de recibo el error administrativo producido en el título porque antes de la publicidad de una capacitación de dicha envergadura, la entidad debió controlar el contenido del mismo con mayor recelo. Es por todo ello que entiendo que fue atinada la medida de

resguardo urgente ya que una capacitación a la comunidad médica debe tender a brindar una atención de salud que abarque el reconocimiento y el respeto de la identidad de género de las personas, en otras palabras el respeto a su género autopercebido y que no se asuma una postura netamente biologicista, por lo que el título del curso es de trascendencia. Dicho texto, amén de que la demandada insiste en que se trató de un error administrativo, no es atendible, máxime cuando se enfatizó que estaba dirigido solo a la comunidad médica porque el acceso on-line estaba abierto a todo público, lo que pudo corroborarse al certificarse ello desde esta Unidad de Jueza, donde además no figuraba prima facie como capacitador el demandante. Es por ello que considero que se ha configurado en dicho momento violencia simbólica, con modalidad mediática, institucional y de manera indirecta contra los derechos sexuales de las personas de la comunidad LGBTIQ+, ya que a través del título del curso se ha perpetuado la desigualdad y discriminación de personas trans, travestis y no binarias, por ser patologizador, derivándose además violencia institucional por haber emanado de una entidad integrada por profesionales médicos, bajo la modalidad mediática por tenerse acceso directo de forma on-line, promoviéndose la difusión de un título patologizante en contra del colectivo bajo estudio. Sin perjuicio de ello, valoro favorablemente el pedido de disculpas formulado en la audiencia de parte de la demandada y en atención a la función socio-educativa de este fuero especializado, es que en definitiva RESUELVO: 1. Declarar que se ha configurado en el presente caso una trama vincular de violencia de género de tipo simbólica, con modalidad mediática, institucional de parte del Consejo Médico de la Provincia de Córdoba en perjuicio de S. A. M. y la comunidad que representa como presidente de la Asociación Civil “Casa de Varones Trans y Familias Córdoba, incidiendo de manera indirecta contra los derechos sexuales de las personas de la comunidad \$LGBTIQ+. 2. Imponer al Consejo médico el pago de la Tasa de Justicia de tres (3) Jus y como reparación que se arbitren los medios necesarios para que el Sr. S. A. M. capacite al personal administrativo y médico de dicha entidad en la importancia del uso correcto de los términos a fin de evitar sesgos patologizantes como los acaecidos en los presentes actuados. 3. Sin perjuicio de lo ordenado en el punto 2, resalto en sentido positivo el pedido de disculpas formulado en la audiencia por el Titular del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Protocolícese, hágase saber, ofíciense y dese copia. FDO.: CÓRDOBA.